

表 1 2021 WHO 分類

胸腺腫の組織型	必須基準
A 型	異型性に乏しい紡錘形の上皮細胞が（少なくとも局所に）認められる；腫瘍全体にわたり未熟 T 細胞が少ないか認められない
AB 型	異型性に乏しい紡錘形の上皮細胞が（少なくとも局所に）認められる；腫瘍全体にわたり未熟 T 細胞が多く認められる
B1 型	胸腺に似た細胞学的，構造的所見が認められる；未熟 T 細胞が多くみられ，髄質分化を認める領域がある；多角または樹状上皮細胞が少なく，集簇がみられない
B2 型	単一または集簇した多角または樹状上皮細胞が増加しており，未熟 T 細胞が多く認められる
B3 型	軽度～中等度の異型性を示す多角上皮細胞のシートが認められる；細胞間橋は認められないか，まれである；T 細胞の混在は少ないか認められない
リンパ性間質を伴う小結節性胸腺腫	異型性に乏しい紡錘形または卵円形の上皮細胞で構成される結節を上皮細胞を含まないリンパ性間質が取り囲んでいる
化生性胸腺腫	異型性に乏しくみえる紡錘形細胞を背景とした上皮細胞の充実性領域で構成される二相型腫瘍；未熟 T 細胞は認められない
その他まれなもの	

その他まれなもの：硬化性胸腺腫，脂肪線維腺腫

臨床病期分類

1981 年，正岡らによって提唱されたⅠ～Ⅳ期の臨床病期分類を一部改変したものが用いられている⁵⁾（表 2）。2025 年 1 月に AJCC の新しい病期分類が発効している。

治療と予後

胸腺腫の治療における第一選択は切除である。これは，胸腺腫においては，血行性，リンパ行性の転移がまれであることによる。

切除後顕微鏡的残存が認められる場合には放射線治療が追加される。肉眼的に腫瘍が残存する場合には放射線治療に加えて化学療法を行うことも考慮される。化学療法としては，プラチナ製剤併用多剤化学療法の報告がなされている。ただし，稀少腫瘍であるため大規模な臨床試験は行われていない。

胸腺腫の治療成績は，病期，手術根治度，組織型，合併症の有無などにより左右される。病期別に切除成績をみると，10 年生存率（合併症死，他病死を除く）でⅠ期 100%，Ⅱ期 95%，Ⅲ期 90%，Ⅳa 期 50%，Ⅳb 期 0% 程度である²⁾。組織分類別にみると，Type A，Type AB，Type B1，B2，B3 の順に 5 年生存率は

表 2 胸腺腫の臨床病期分類（正岡分類 改変）

Ⅰ期	肉眼的かつ顕微鏡的に完全に被包されている
Ⅱ期	
(a)	顕微鏡的に被膜を越えて浸潤している
(b)	肉眼的に周辺脂肪組織に浸潤している，もしくは肉眼的に縦隔胸膜または心膜への癒着を認めるが ⁶⁾ ，いずれも越えていない
Ⅲ期	肉眼的に周囲臓器（心臓，大血管，肺）に浸潤している
(a)	大血管への浸潤を認めない
(b)	大血管への浸潤を認める
Ⅳ期	
(a)	胸膜または心嚢への播種を認める
(b)	リンパ行性または血行性転移を認める

100%，100%，94.1%，75%，70%と報告されている⁶⁾。

文 献

- 1) Mullen B, et al : Ann Thorac Surg 42 : 338, 1986
- 2) Drachman DB : N Engl J Med 330 : 1797, 1994
- 3) Seki S, et al : Eur J Radiol 83 : 835, 2014
- 4) Marx A, et al : J Thorac Oncol 10 : 1383, 2015
- 5) Masaoka A, et al : Cancer 48 : 2485, 1981
- 6) Wright CD : Crit Rev Oncol Hematol 65 : 109, 2008